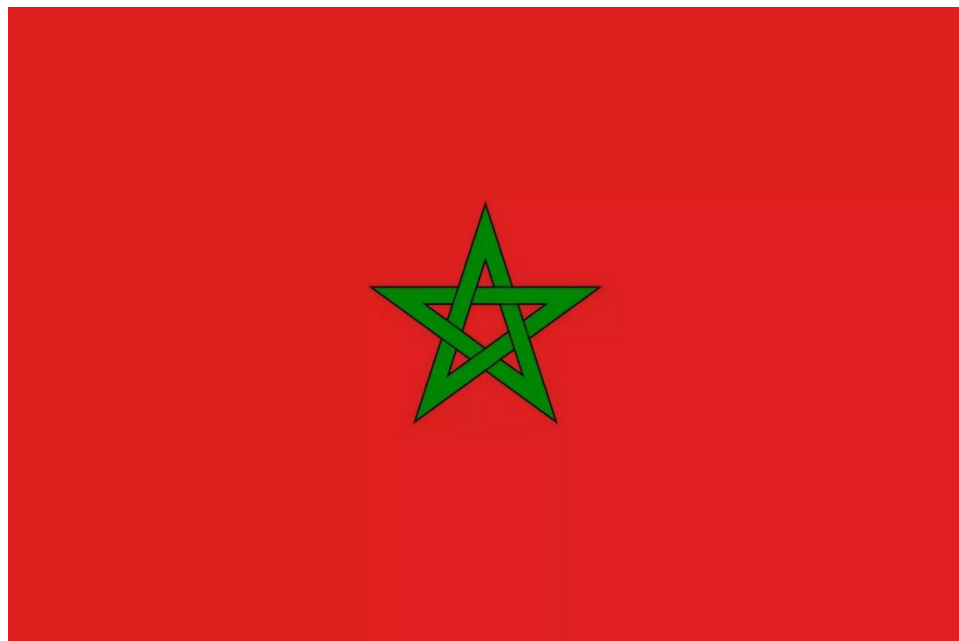


Concours



Epreuve Commune Nationale 10 juin 2018

Avec Justification



[Lien Page Instagram](#)

**PRÉPA
CONCOURS
MSPS**



**OFFRE DE PRÉPARATION AU CONCOURS COMMUN
DE RECRUTEMENT- INSCRIPTION OUVERTE**

1) Parmi les piliers du Plan Santé 2025, on trouve :

- A) Améliorer la gouvernance et optimiser l'allocation et l'utilisation des ressources
- B) Lancer de nouveaux programmes et stratégies sanitaires
- C) Organiser l'offre de soins national
- D) Renforcer l'encadrement législatif et réglementaire du secteur de la santé

2) Les bénéficiaires des prestations du régime d'assistance médicale (RAMED) sont :

- A) Les personnes qui ne sont assujetties à aucun régime d'assurance maladie obligatoire
- B) Leur(s) conjoint(s)
- C) Leurs parents
- D) Leurs enfants à charge, non-salariés, âgés de 24 ans au plus

3) L'offre de soins en mode fixe dans le secteur public est composée des réseaux suivants :

- A) Réseau des établissements de soins de santé primaires
- B) Réseau des établissements hospitaliers des Forces Armées Royales
- C) Réseau des établissements médico-sociaux publics
- D) Réseau intégré des soins d'urgences médicales

4) Pour les bénéficiaires du RAMED, la contribution concerne :

- A) La population en situation de pauvreté et de vulnérabilité
- B) Seulement la population en situation de pauvreté
- C) Seulement la population en situation de vulnérabilité
- D) Aucune proposition n'est juste

5) Selon le décret de la carte sanitaire, les schémas régionaux de l'offre de soins :

- A) Ne peuvent être révisés qu'après la fin de la période de leur validité
- B) Sont approuvés par les arrêtés du ministre de la santé
- C) Sont établis par les directions régionales de la santé concernées
- D) Sont établis pour une période de trois ans

6) Parmi les attributions de la direction régionale de santé :

- A) L'élaboration des plans d'action concernant l'état de santé au niveau de la province/préfecture
- B) La coordination entre les services déconcentrés et les établissements sanitaires
- C) La gestion des ressources humaines
- D) La protection de la santé publique et la veille sanitaire

7) L'offre publique de soins en mode mobile est composée des réseaux suivants :

- A) Le réseau des établissements de soins de santé primaires
- B) Le réseau hospitalier
- C) Le réseau intégré des soins d'urgence médicale
- D) Aucune proposition n'est juste

8) La stratégie du Ministère de la santé accorde une importance à la population spécifique, on désigne par cette population :

- A) La population carcérale
- B) Les migrants
- C) Les nouveau-nés
- D) Les personnes âgées

9) Les établissements qui ne font pas partie du réseau hospitalier sont :

- A) Les centres d'hémodialyse
- B) Les centres de soins palliatifs
- C) Les centres de transfusion
- D) Les centres régionaux d'oncologie

10) Lorsque la superficie d'une province est étendue, son réseau hospitalier peut être renforcé par :

- A) Centre de référence
- B) Clinique de jour
- C) Hôpital de proximité
- D) Pôle d'excellence

11) Les établissements de soins de santé primaires sont appuyés par :

- A) Les centres d'addictologie
- B) Les centres de consultations spécialisées
- C) Les centres de diagnostic et de traitement des maladies respiratoires
- D) Les laboratoires de santé publique

12) Les urgences médico-hospitalières complètes (UMH-C) sont assurées par :

- A) Les centres hospitaliers interrégionaux
- B) Les centres hospitaliers provinciaux
- C) Les centres hospitaliers préfectoraux
- D) Les centres hospitaliers régionaux

13) Une augmentation significative et inhabituelle de la fréquence d'une maladie dans le temps et dans l'espace est une :

- A) Endémie
- B) Pandémie
- C) Épidémie
- D) Aucune proposition n'est juste

14) Font partie du système national de santé marocain :

- A) La médecine traditionnelle
- B) Le secteur privé
- C) Les services de santé relevant des collectivités locales
- D) Les services des FAR

15) L'organisation de l'offre de soins s'effectue conformément :

- A) Aux orientations de l'OMS
- B) Aux schémas régionaux de l'offre de soins
- C) À l'organisation hospitalière
- D) À la carte sanitaire

16) Le projet d'établissement hospitalier (PEH) est un :

- A) Moyen de mobilisation et de responsabilisation des acteurs
- B) Outil de management participatif
- C) Outil de planification
- D) Projet des professionnels de l'hôpital

17) Le territoire de santé est constitué par :

- A) La circonscription sanitaire
- B) La délégation sanitaire
- C) Le centre hospitalier universitaire
- D) Le territoire de santé interrégional

18) Selon la loi 34-09 sur le système de santé et l'offre de soins, le droit à la protection de la santé est une :

- A) Responsabilité de l'État et de la société
- B) Responsabilité des citoyens
- C) Responsabilité des citoyens et de l'État
- D) Aucune proposition n'est juste

19) Les directions de l'administration centrale du ministère de la santé comprennent :

- A) La direction de la planification et des ressources financières
- B) La direction de la population



- C) La direction de lutte contre les maladies
- D) La direction des ressources humaines et contentieux

20) Les principes du système de santé marocain :

- A) L'adoption de l'approche genre en matière de service de santé
- B) L'égalité d'accès aux soins
- C) L'équité dans la répartition spatiale des ressources sanitaires
- D) La solidarité

21) Les objectifs du développement durable (ODD) :

- A) Six sont liés indirectement à la santé
- B) Sont au nombre de 15
- C) Sont au nombre de 17
- D) Trois sont liés directement à la santé

22) Le Plan Santé 2025 cible les nouveaux programmes suivants :

- A) L'hépatite virale B, l'hypothyroïdie et la prévention des maladies cardiovasculaires
- B) L'hépatite virale C, la prévention des maladies cardiovasculaires et la surdité chez l'enfant
- C) L'hépatite virale C, le diabète et l'obésité
- D) Les maladies rares, l'insuffisance rénale chronique terminale et la procréation médicalement assistée

23) Les prestations de soins et services en mode mobile peuvent être effectuées au moyen de :

- A) Caravanes médicales spécialisées
- B) Hôpitaux mobiles
- C) Unités médicales mobiles
- D) Visites à domicile

24) Les fonctions de soins d'urgences médicales sont :

- A) Au nombre de 14 fonctions
- B) Au nombre de 15 fonctions
- C) Au nombre de 16 fonctions
- D) Au nombre de 17 fonctions

25) Les services d'une direction régionale de la santé comprennent :

- A) L'observatoire régional de la santé
- B) Le service de l'approvisionnement

C) Le service de l'offre de soins et des équipements et de maintenance

D) Le service des ressources humaines

26) L'assurance maladie obligatoire des étudiants (AMO-E) est gérée par :

A) L'ANAM

B) La CNOPS

C) La CNSS

D) Le Ministère de la santé

27) Les composantes de la couverture médicale de base (CMB) sont :

A) L'AMI

B) L'AMO

C) La CNOPS

D) Le RAMED

28) Parmi les indicateurs de l'état de santé, on trouve :

A) Disponibilité des médicaments essentiels

B) Espérance de vie à la naissance

C) Taux d'accouchement en milieu surveillé

D) Taux de mortalité maternelle

29) On entend par prestations d'hôpital de jour :

A) Les prestations de soins de santé primaires qui peuvent être rendues dans la journée

B) Les prestations de soins et services hospitaliers qui peuvent être rendues 24/24

C) Les prestations de soins et services hospitaliers qui peuvent être rendues dans la journée avec hébergement

D) Les prestations de soins et services hospitaliers qui peuvent être rendues dans la journée sans hébergement

30) Selon l'enquête nationale sur la population et la santé familiale (ENPSF) 2018, le ratio de la mortalité maternelle (pour 100.000 naissances vivantes) est de :

A) 70,1

B) 71,3

C) 72,6

D) 73,8

1) Parmi les piliers du Plan Santé 2025, on trouve :

- A) Améliorer la gouvernance et optimiser l'allocation et l'utilisation des ressources
- B) Lancer de nouveaux programmes et stratégies sanitaires
- C) Organiser l'offre de soins national
- D) Renforcer l'encadrement législatif et réglementaire du secteur de la santé

Pilier 1 : Organiser et développer l'offre de soins en vue d'améliorer l'accès aux services de santé

Pilier 2 : Renforcer les programmes nationaux de santé et de lutte contre les maladies

Pilier 3 : Améliorer la gouvernance et optimiser l'allocation et l'utilisation des ressources

2) Les bénéficiaires des prestations du régime d'assistance médicale (RAMED) sont :

- A) Les personnes qui ne sont assujetties à aucun régime d'assurance maladie obligatoire
- B) Leur(s) conjoint(s)
- C) Leurs parents
- D) Leurs enfants à charge, non-salariés, âgés de 24 ans au plus



Bénéficiaires par éligibilité

- Personnes qui ne sont assujetties à aucun régime d'AMO et ne disposant pas de ressources suffisantes pour faire face aux dépenses inhérentes aux prestations médicales
- Leur (s) conjoint (s) ;
- Leurs enfants à charge, non salariés, âgés de 21 ans au plus et non couverts par une assurance maladie obligatoire de base. Cette limite d'âge peut être prorogée jusqu'à 26 ans en cas de poursuite des études dûment justifiée ;
- Leurs enfants handicapés quel que soit leur âge, qui sont dans l'impossibilité totale et permanente de se livrer à une activité rémunérée par suite d'incapacité physique ou mentale.
- Enfants qui vivent sous le même toit que les personnes bénéficiaires citées ci-dessus, et qui se trouvent à leur charge effective, totale et permanente, sont, à condition d'en apporter la preuve, admis au bénéfice des prestations garanties au titre de l'assistance médicale (**Art. 116 L**)

Bénéficiaires de droit

- ✓ les pensionnaires des établissements de bienfaisance, orphelinats, hospices, ou des établissements de rééducation et de tout établissement public ou privé à but non lucratif hébergeant des enfants abandonnés ou adultes sans famille;
- ✓ les pensionnaires des établissements pénitentiaires;
- ✓ les personnes sans domicile fixe.
- ✓ Les personnes bénéficiant de la gratuité de par la loi (pupilles de la nation, ...)

3) L'offre de soins en mode fixe dans le secteur public est composée des réseaux suivants :

A) Réseau des établissements de soins de santé primaires

B) Réseau des établissements hospitaliers des Forces Armées Royales

C) Réseau des établissements médico-sociaux publics

D) Réseau intégré des soins d'urgences médicales



4. Par réseaux d'établissements de santé : **RESSP, RH, RISUM, REMS**

4) Pour les bénéficiaires du RAMED, la contribution concerne :

- A) La population en situation de pauvreté et de vulnérabilité
- B) **Seulement** la population en situation de pauvreté
- C) **Seulement** la population en situation de vulnérabilité
- D) Aucune proposition n'est juste

ART. 6. - Pour le bénéfice des prestations du régime d'assistance médicale, les personnes reconnues éligibles en vertu des articles 3 et 4 ci-dessus sont classées, en fonction du revenu ou du patrimoine pondérés prévus à l'article 25 et 26 ci-dessous, en deux catégories :

- ✓ les personnes en situation de pauvreté ;
- ✓ les personnes en situation de vulnérabilité.

5) Selon le décret de la carte sanitaire, les schémas régionaux de l'offre de soins :

- A) Ne peuvent être révisés qu'après la fin de la période de leur validité
- B) Sont approuvés par les arrêtés du ministre de la Santé
- C) Sont établis par les directions régionales de la santé concernées
- D) Sont établis pour une période de trois ans

6) Parmi les attributions de la direction régionale de santé :

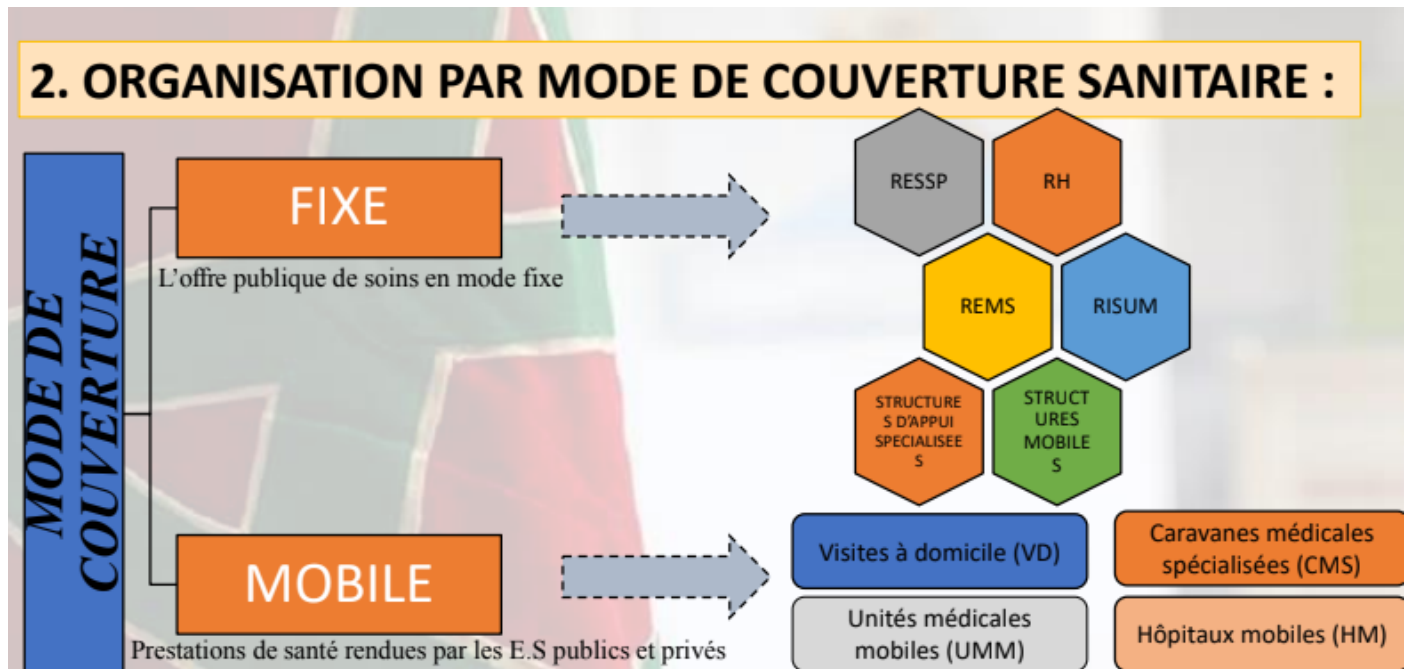
- A) L'élaboration des plans d'action concernant l'état de santé au niveau de la province/préfecture
- B) La coordination entre les services déconcentrés et les établissements sanitaires
- C) La gestion des ressources humaines
- D) La protection de la santé publique et la veille sanitaire

7) L'offre publique de soins en mode mobile est composée des réseaux suivants :

- A) Le réseau des établissements de soins de santé primaires



- B) Le réseau hospitalier
- C) Le réseau intégré des soins d'urgence médicale
- D) Aucune proposition n'est juste



8) La stratégie du Ministère de la santé accorde une importance à la population spécifique, on désigne par cette population :

- A) La population carcérale
- B) Les migrants
- C) Les nouveau-nés
- D) Les personnes âgées

9) Les établissements qui ne font pas partie du réseau hospitalier sont :

- A) Les centres d'hémodialyse
- B) Les centres de soins palliatifs
- C) Les centres de transfusion
- D) Les centres régionaux d'oncologie

10) Lorsque la superficie d'une province est étendue, son réseau hospitalier peut être renforcé par :

- A) Centre de référence



- B) Clinique de jour
- C) Hôpital de proximité**
- D) Pôle d'excellence

Lorsque la superficie d'une province sanitaire est étendue, son réseau hospitalier peut être renforcé par la création d'hôpitaux de proximité.

11) Les établissements de soins de santé primaires sont appuyés par :

- A) Les centres d'addictologie
- B) Les centres de consultations spécialisées
- C) Les centres de diagnostic et de traitement des maladies respiratoires**
- D) Les laboratoires de santé publique**

4. ORGANISATION PAR RESEAUX D'ETABLISSEMENTS DE SANTE:

❑ RESSP :

Les centres de référence pour la santé reproductive (CRSR)

Les centres de diagnostic et de traitement des maladies respiratoires (CDTMR)

laboratoires de diagnostic épidémiologique et d'hygiène du milieu (LEHM)

Les établissements de soins de santé primaires (ESSP) sont appuyés par des structures spécialisées qui assurent les activités relevant des programmes sanitaires.

Centre de consultation, d'information et de formation pour tout ce qui a trait aux activités de contraception et de fertilité;
Appuyer les ESSP qui fournissent des prestations de PF.

Assure la prise en charge des cas de tuberculose;
Appuie les ESSP qui interviennent dans le programme des maladies respiratoires.

- Soutenir les programmes de prévention et de lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles;
- Contrôle de certains produits à risque et au diagnostic biologique et immunologique des maladies faisant l'objet d'un programme structuré de lutte.

12) Les urgences médico-hospitalières complètes (UMH-C) sont assurées par :

- A) Les centres hospitaliers interrégionaux
- B) Les centres hospitaliers provinciaux
- C) Les centres hospitaliers préfectoraux
- D) Les centres hospitaliers régionaux**

📌 OFFRE DE PRÉPARATION AU
CONCOURS COMMUN DE
RECRUTEMENT- INSCRIPTION OUVERTE

POUR PLUS D'INFOS
0707503186 - 0641663786

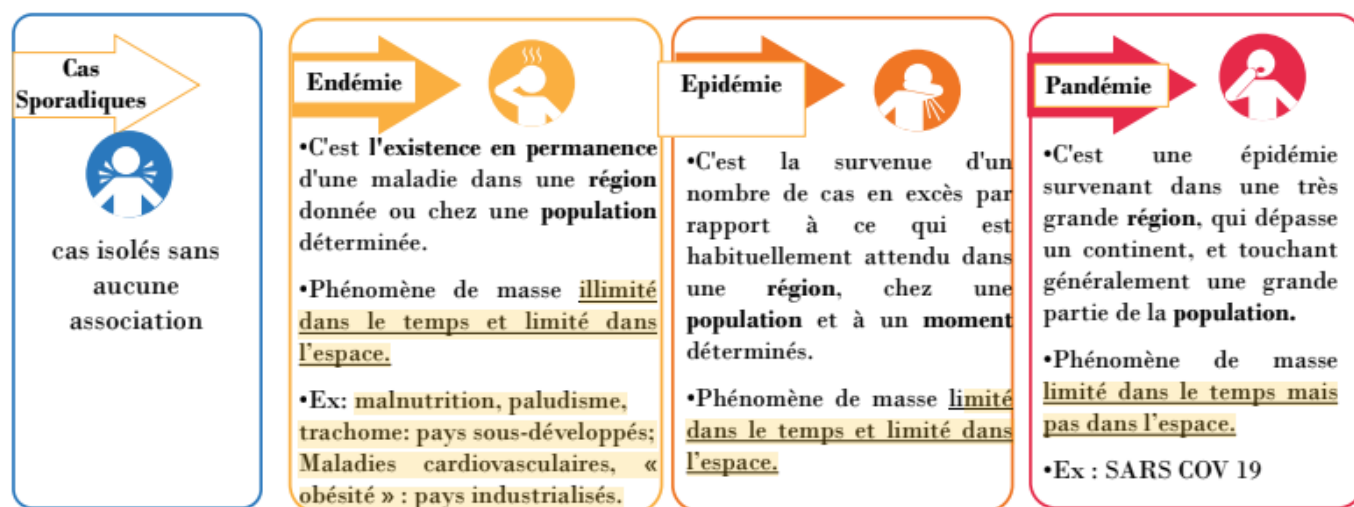
PRÉPA
CONCOURS
MSPS

Niveaux de soins hospitaliers		Niveau 1		Niveau 2	Niveau 3
Territoire de santé		Province		Région	inter-Régional
Prestations		HP	CHP	CHR	CHU
Urgences	UMHB	x	x	x	x
	UMHC			x	x
	UMHS				x
	Soins intensifs	x	x	x	x
	Réanimation polyvalente		x	x	x
	Réanimation obstétricale				x
	Réanimation néonatale				x

13) Une augmentation significative et inhabituelle de la fréquence d'une maladie dans le temps et dans l'espace est une :

- A) Endémie
- B) Pandémie
- C) Épidémie**
- D) Aucune proposition n'est juste

Evolution d'un phénomène de santé



14) Font partie du système national de santé marocain :

- A) La médecine traditionnelle
- B) Le secteur privé
- C) Les services de santé relevant des collectivités locales BMH/BCH
- D) Les services des FAR

15) L'organisation de l'offre de soins s'effectue conformément :

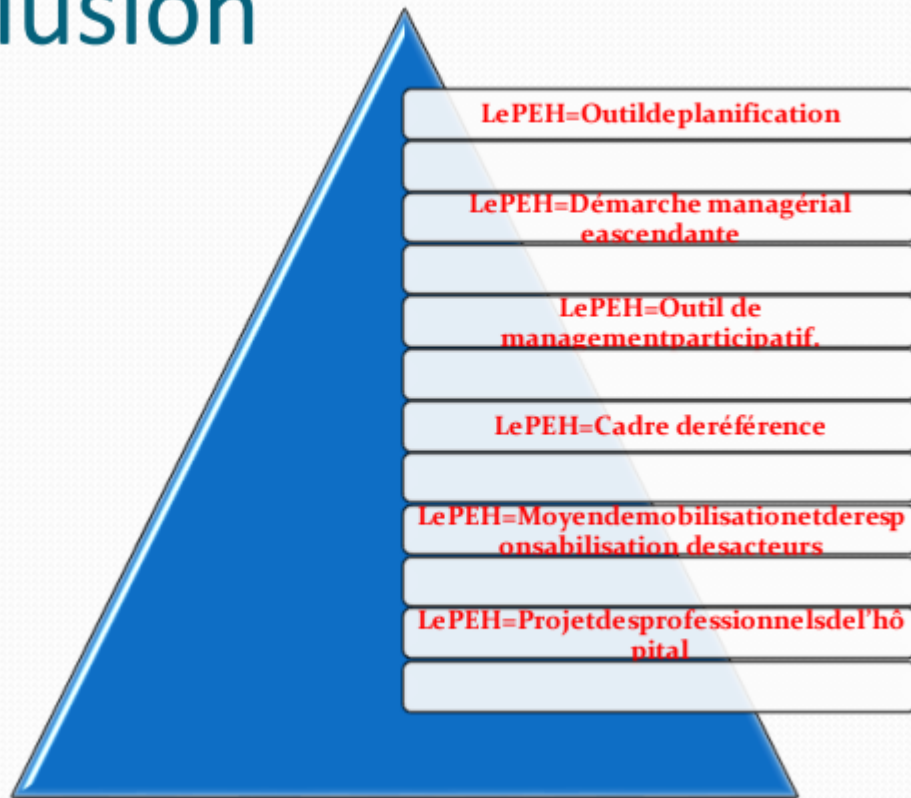
- A) Aux orientations de l'OMS
- B) Aux schémas régionaux de l'offre de soins
- C) À l'organisation hospitalière
- D) À la carte sanitaire

16) Le projet d'établissement hospitalier (PEH) est un :

- A) Moyen de mobilisation et de responsabilisation des acteurs
- B) Outil de management participatif
- C) Outil de planification
- D) Projet des professionnels de l'hôpital



Conclusion



17) Le territoire de santé est constitué par :

- A) La circonscription sanitaire
- B) La délégation sanitaire
- C) Le centre hospitalier universitaire
- D) Le territoire de santé interrégional

18) Selon la loi 34-09 sur le système de santé et l'offre de soins, le droit à la protection de la santé est une :

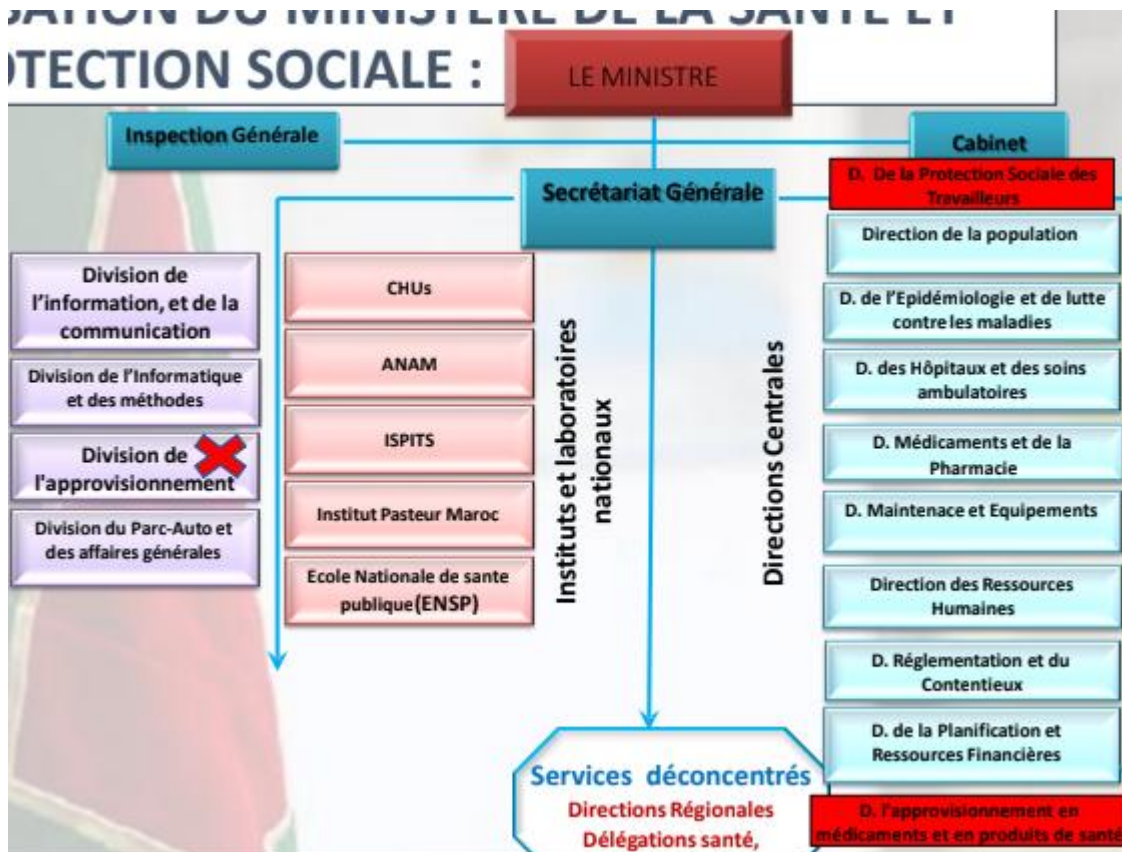
- A) Responsabilité de l'État et de la société
- B) Responsabilité des citoyens
- C) Responsabilité des citoyens et de l'État
- D) Aucune proposition n'est juste



- Le droit à la protection de la santé est une responsabilité de l'État et de la société.

19) Les directions de l'administration centrale du ministère de la santé comprennent :

- A) La direction de la planification et des ressources financières
- B) La direction de la population
- C) La direction de lutte contre les maladies
- D) La direction des ressources humaines et contentieux



20) Les principes du système de santé marocain :

- A) L'adoption de l'approche genre en matière de service de santé
- B) L'égalité d'accès aux soins
- C) L'équité dans la répartition spatiale des ressources sanitaires
- D) La solidarité

LES PRINCIPES DU SYSTÈME NATIONAL DE SANTÉ

- **L'égalité** d'accès aux soins et service de santé
- **La continuité** dans la dispensions des services de santé
- **L'équité** dans la répartition spatiales des ressources et les infrastructures et les services de santé
- **La bonne gouvernance**
- **Adoption de l'approche genre** dans l'élaboration des politiques, les programmes et les stratégie sanitaire
- **Gestion** axé sur les résultats et la réédition des comptes
- **La synergie des moyens**
- **Mobilisation** de tous les citoyens et citoyennes, des institutions et établissements des deux secteurs publique et privé, des associations de la société civile, et leur implication dans la mise en œuvre de la politique de l'État relative à la prévention des épidémies, maladies et autres risques de la santé, ainsi que celle liée aux programmes d'amélioration de l'état de santé et l'offre de soins de santé de base pour la population

21) Les objectifs du développement durable (ODD) :

- A) Six sont liés indirectement à la santé
- B) Sont au nombre de 15
- C) Sont au nombre de 17
- D) Trois sont liés directement à la santé

22) Le Plan Santé 2025 cible les nouveaux programmes suivants :

- A) L'hépatite virale B, l'hypothyroïdie et la prévention des maladies cardiovasculaires
- B) L'hépatite virale C, la prévention des maladies cardiovasculaires et la surdité chez l'enfant
- C) L'hépatite virale C, le diabète et l'obésité
- D) Les maladies rares, l'insuffisance rénale chronique terminale et la procréation médicalement assistée

Action 39. Lancer et mettre en œuvre le plan «Maroc sans hépatite virale C ».

Mesure 39.1. Mettre en place un programme de dépistage et de diagnostic de l'HVC.

Mesure 39.2. Implanter un dispositif de prise en charge de l'HVC et améliorer l'accès aux soins de l'HVC.

Mesure 39.3. Mettre en place un système de genèse de l'information stratégique relatif aux hépatites virales.

Mesure 39.4. Renforcer la prévention des HVC et HVB et intégrer les activités dans les programmes sanitaires existants.

Mesure 39.5. Renforcer le partenariat dans le domaine des HV et mettre en place des mécanismes de coordination et de gouvernance de la réponse nationale.



Action 46. Lancer des programmes pour les maladies rares et inflammatoires et les maladies respiratoires chroniques.

Mesure 46.1. Évaluer l'état des lieux des maladies rares et des maladies inflammatoires chroniques.

Mesure 46.2. Créer une consultation pour la prise en charge des maladies rares et inflammatoires.

Mesure 46.3. Évaluer l'état des lieux des maladies respiratoires chroniques (asthme et broncho-pneumopathie chronique obstructive).

Mesure 46.4. Élaborer un plan national de prévention et de contrôle des maladies respiratoires chroniques.

Action 37. Renforcer les programmes de lutte contre la cécité et la surdité et le programme de la santé bucco-dentaire.

Mesure 37.1. Renforcer la stratégie nationale de prise en charge de la cataracte cécitante, du glaucome, de la rétinopathie diabétique, de la basse vision et de la dégénérescence maculaire liée à l'âge.

Mesure 37.2. Mettre en œuvre la stratégie nationale de prise en charge de la surdité.

Mesure 37.3. Renforcer la prophylaxie et améliorer la prise en charge des affections bucco-dentaires.

Mesure 37.4. Faire le plaidoyer pour l'activation de l'approbation du projet de loi 25-14 relatif à l'exercice de la profession de préparateur et de manipulateur de produits de santé et actualiser le dahir de 1960 relatif à l'exercice de la profession de la médecine dentaire.

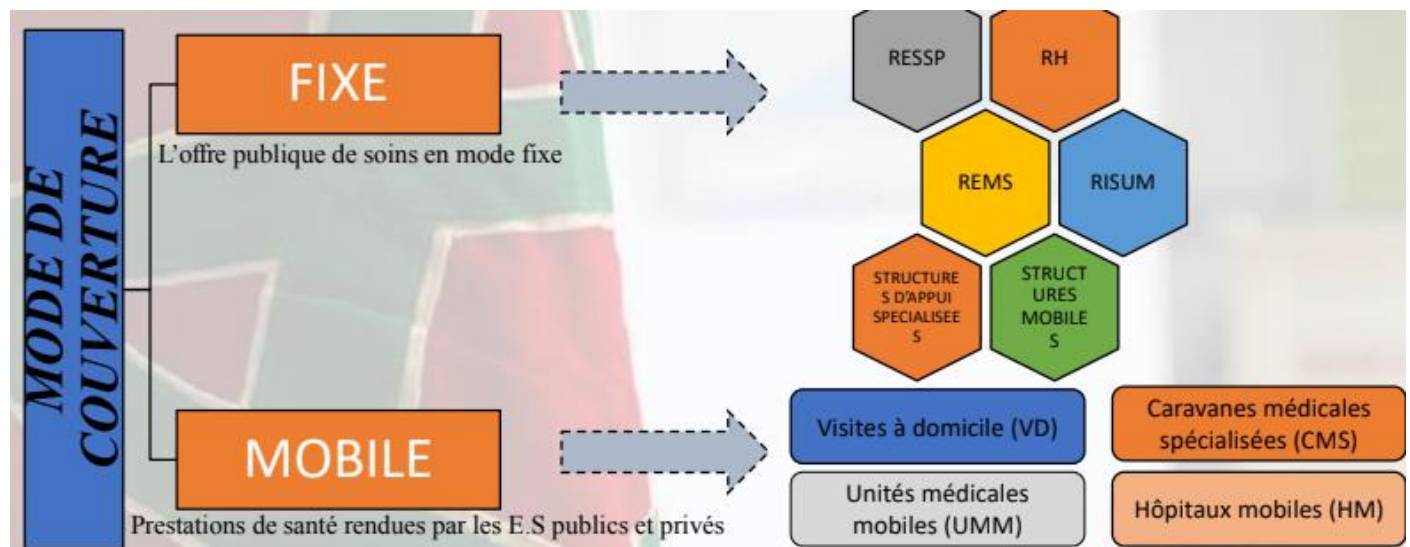
23) Les prestations de soins et services en mode mobile peuvent être effectuées au moyen de :

A) Caravanes médicales spécialisées

B) Hôpitaux mobiles

C) Unités médicales mobiles

D) Visites à domicile



24) Les fonctions de soins d'urgences médicales sont :

A) Au nombre de 14 fonctions

B) Au nombre de 15 fonctions

C) Au nombre de 16 fonctions

D) Au nombre de 17 fonctions

1. LES URGENCES MEDICALES DE PROXIMITE (UMP)

Ce sont des soins d'urgences médicales prodigués dans les centres de santé ruraux et urbains du deuxième niveau implantés dans les chefs-lieux des circonscriptions sanitaires et distants des hôpitaux de référence. 7 fonctions de soins d'urgence sont préconisées à ce niveau (F1 à F7) :

- F1 : Permanence 24/24h (*Garde ou Astreinte*) ;
- F2 : Diagnostic clinique des détresses vitales ;
- F3 : Gestes et manœuvres de premier secours : *massage cardiaque, aspiration/libération des voies aériennes supérieures, Oxygène, pose d'une perfusion, pose d'un garrot compressif, sonde vésicale, administration parentérale de médicaments vitaux (antalgique, sédatif, antispasmodique, antibiotique, etc.), suture de plaie simple, mise en condition de l'urgent pour son transfert à un niveau supérieur* ;
- F4 : Contention provisoire et immobilisation de fractures par attelles (*minerves, attelles*)
- F5 : Surveillance du patient (*salle d'observation*) ;
- F6 : Examen biologique de base : 3 paramètres (*Automate*) : NFS, Glycémie, urée ;
3 paramètres (*Bandelettes réactifs*) albuminurie, glucosurie, acétonurie ;
- F7 : Transfert sanitaire simple 24/24.

2. LES URGENCES MEDICO-HOSPITALIERES DE BASE (UMHB)

Elles sont prodiguées au niveau des CHP (Hôpitaux Locaux, Hôpitaux Provinciaux et Préfectoraux). En plus des fonctions UMP on trouve 5 autres fonctions à ce niveau (F8 à F12).

- F8 : Gestes de ressuscitation et de réanimation (F3 + Déchoquage cardio-vasculaire, sédation, intubation/ventilation, Sonde gastrique, monitoring)
- F9 : Examen complémentaire de Base : (F6 + Echographie, ionogramme, bactériologie, immunologie) ;
- F10 : Transfusion ;
- F11 : Hospitalisation ;
- F12 : Intervention chirurgicale (Bloc opératoire).

Elles sont prodiguées au niveau des CHR et CHU (Hôpitaux Régionaux et Centres Hospitaliers Universitaires). En plus des fonctions des UMHB on trouve les 4 autres fonctions suivantes à ce niveau (F13 à F16) :

- F13 : Fonction de réanimation hospitalière polyvalente (prise en charge complète des défaillances viscérales aiguës mettant directement en jeu le pronostic vital) ;
- F14 : Examens complémentaires complets : (F11 + TDM/IRM, explorations fonctionnelles ou invasives, virologie, etc.) ;
- F15 : Transfert SMUR en plus de F9 ;
- F16 : Régulation des appels médicaux.

25) Les services d'une direction régionale de la santé comprennent :

- A) L'observatoire régional de la santé
- B) Le service de l'approvisionnement
- C) Le service de l'offre de soins et des équipements et de maintenance
- D) Le service des ressources humaines

Chaque direction régionale de la santé est composée de **6 services et 2 unités** suivants:

► **Les services :**

1. Service de la santé publique
2. Service de l'offre de soins
3. Observatoire régional de santé
4. Service des ressources financières, de la logistique et du partenariat
5. Service des ressources humaines et contentieux
6. Service des équipements et de la maintenance.



► **Les unités :**

1. Une unité régionale d'approvisionnement et de pharmacie
2. Une unité régionale de communication et information.

26) L'assurance maladie obligatoire des étudiants (AMO-E) est gérée par :

- A) L'ANAM
- B) La CNOPS
- C) La CNSS
- D) Le Ministère de la santé

27) Les composantes de la couverture médicale de base (CMB) sont :

- A) L'AMI
- B) L'AMO
- C) La CNOPS
- D) Le RAMED

28) Parmi les indicateurs de l'état de santé, on trouve :

- A) Disponibilité des médicaments essentiels
- B) Espérance de vie à la naissance
- C) Taux d'accouchement en milieu surveillé
- D) Taux de mortalité maternelle



29) On entend par prestations d'hôpital de jour :

- A) Les prestations de soins de **santé primaires** qui peuvent être rendues dans la journée
- B) Les prestations de soins et services hospitaliers qui peuvent être rendues **24/24**
- C) Les prestations de soins et services hospitaliers qui peuvent être rendues dans la journée avec hébergement
- D) Les prestations de soins et services hospitaliers qui peuvent être rendues dans la journée sans hébergement

30) Selon l'enquête nationale sur la population et la santé familiale (ENPSF) 2018, le ratio de la mortalité maternelle (pour 100.000 naissances vivantes) est de :

- A) 70,1
- B) 71,3
- C) 72,6
- D) 73,8

En utilisant la méthode d'estimation directe de la mortalité maternelle sur un échantillon de 121715 ménages (64577 en milieu urbain et 57148 en milieu rural), l'ENPSF-2018 a fourni un Ratio de Mortalité Maternelle de 72,6 pour 100000 naissances vivantes pour la période 2015-2016 (44,6 et 111,1 pour 100 000 NV respectivement en urbain et en rural), soit une diminution de 35% entre 2010 et 2016 et un taux de réduction annuelle moyenne de 7%.

